**جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) ***

# طلب علاج أول مرة / متردد

**إسم المريض رباعياً :** ايمان عطا احمد عطا

**المحافظة :** القاهره **الحي / المدينة :** التبين **العنوان :** 52 ش بلال حكر التبين البحري

**رقم البطاقة :** 28801200104704 **رقم التليفون :** 01003481193 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026

**العمر(تاريخ الميلاد) :** 20-01-1988 **المهنة :** ربه منزل

---

## الإقرار

**أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك**

**الإخصائي الاجتماعي**
**التوقيع:**(----------)

**المقر بما فيه**
**التوقيع:**(----------)

**التشخيص الإكلينيكي :** سرطان بالثدي (مبادرة)

**نتائج الأبحاث :** (مرفق)

**التشخيص النهائي :** سرطان بالثدي (مبادرة)

**خطة العلاج :** أبحاث أورام رنين مغناطيسي علي الفقرات الظهريه بالصبغه [12771]

**قسم العلاج :** الاورام

**التعليق على التشخيص :** ----------

## تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

**الاسم:** د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
**الاسم:** د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
**الاسم:** د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

**أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.**
**كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.**

**تعتمد صحة البيانات المرفقة**
**رئيس اللجنة و مدير المستشفي.**

**تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.**

## أعضاء اللجنة

**ا.د/** ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

## قرار اللجنة

**التشخيص النهائي :** ----------
**خطة العلاج :** ----------
**المستشفي :** ----------**قسم :** ----------
**جهة العلاج :** ----------**نفقات :** ----------
**ملاحظات :** ----------

| رئيس | مدير عام | ختم |
|---|---|---|
| المجلس الطبي المتخصص | مديرية الشئون الصحية | شعار الجمهورية |

**Name:** ايمان عطا احمد عطا
**National ID:** 28801200104704

## تقرير طبي

**السيد**

**تحية طيبة وبعد,,**

| | |
|---|---|
| **إيماء للطلب المقدم من** | **بشأن تقرير طبي للمريض** |
| **بقسم:** | **رقم طبي:** |

**نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته**

| | |
|---|---|
| **تاريخ وساعة الدخول :** -- --:-- yyyy-mm-dd | **تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026 |

**وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة**

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي MRI of thoracic spine with contrast

| | |
|---|---|
| **التاريخ :** 05-07-2026 | **الوقت :** -- --:-- |
| | **الطبيب المعالج :** د/شيماء لاشين |




DMS
صفحة كمبيوتر وبطن وجه ظهر صيغة
تدعيم




National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Patient Name** | ايمان عطا احمد | **Case No.** | **328004** |
| **Sex/Age** | **Female 38 Y** | **Patient No.** | **24010** |
| **Registered Date** | **23/6/2026 09:08:53 AM** | **Referred By Dr.** | **Out Patient** |
| **Validation Date** | **13/7/2026 11:21:00 AM** | **Branch** | **Gustave Roussy** |
| **Reporting Date** | **16/7/2026 01:19:18 PM** | **Pathology No.** | **1966/26** |

**Clinical Data:** Left breast mass (BIRADS 5).

**Nature of Specimen**: Tru-cut biopsy, collected on 23/06/2026, at 12:40 am. Cold ischemia time is 20 seconds.

**Gross Examination:**
- Four grey-white tissue cores, ranging in size between 1.0 cm & 1.5 cm long, totally submitted.

**Technique:**
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

**Microscopic examination:**
- **Histologic type:** Invasive duct carcinoma.
- **Histologic grade:** 2 (Differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1)?
- **Ductal carcinoma in situ:** Absent.
- **Microcalcification:** Present.
- **Angioinvasion:** Absent.
- **Perineural invasion:** Absent
- **Tumor infiltrating lymphocytes (TILs):** Mild.

**Results:**
*** IPT (All controls showed appropriate reactivity):**
- ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 60% of tumor cells (score 7/8).



Breast Biopsy
[[DOCTYPE:BREAST_BIOPSY]]

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Patient Name** | ايمان عطا احمد | **Case No.** | **328004** |
| **Sex/Age** | **Female 38 Y** | **Patient No.** | **24010** |
| **Registered Date** | **23/6/2026 09:08:53 AM** | **Referred By Dr.** | **Out Patient** |
| **Validation Date** | **13/7/2026 11:21:00 AM** | **Branch** | **Gustave Roussy** |
| **Reporting Date** | **16/7/2026 01:19:18 PM** | **Pathology No.** | **1966/26** |

- Her2: Faint incomplete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 1+).
- Ki67%: 35%.

**Conclusion:**

**Left breast mass, Tru-cut biopsy:**

-Invasive duct carcinoma, Grade 2.

**IPT:**

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 7/8).
- Her2: Low (score +1).
- Ki67%: 35%.

***Scoring system: "ER, PR"*

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%
and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

*** Scoring system: "Her2"*

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of
the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.



Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

منطقة حلوان الطبية
مستشفى حلوان العام

Name : ايمان عطا احمد
Date :20-06-202:6

## Bilateral breast non contrast mammography and sonography REVEALED:-

- **Acr : C**
- **Left breast show Multiple ( at least 5 ) asymmetry & soft tissue solid masses with no vascularity on Doppler study showing peripheral edge shadowing & posterior acoustic enhancement one of them at 2 o'clock away from nipple measuring about 12x 15 mm , another one is seen at the axillary tail measuring about 11x19 mm and another one is seen at 3 o'clock pre-areolar , some ducts show dense calcifications BIRADS V.**
- left axilla showing multiple suspicious LNs globular in shape and peripherally attenuated .
- Right breast showing fibroadenosis with multiple adenotic nodules the largest one about 5.5 mm at 10 o'clock BIRADS III .

**Conclusion :**

- left sided Multiple asymmetry with suspicious masses and suspicious LNs for biopsy & contrast enhanced mammography breast study .

**Dr/ Soha Ibrahim**

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

جوستافروسي

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

10/04/2026

# MDT FORM

| | | | |
|---|---|---|---|
| ne: | ايمان عطا احمد عطا | MRN: | 12561 |
| : | 39 Y | ID: | 28801200104704 |
| nopausal Sta | PRE | Phone: | 01003481193 |
| S SCORE: | | Marital Status: | |
| : | | Family History: | |
| Morbidity: | FREE | Reason Of MDT: | NEW CASE |

## Clinical Data:

IDC GII

8/8 **PR:** 7/8 **HER2:** 1 **KI67:** 35%

**omammography:**

**s Workup:**

**ory:**

se of left breast cancer multiple mass with axilly lns er 8/8, pr 7/8, her2 +1
7% 35% ct cap >> multiple HFLs, iliac bone secloretic lesions dynamic
live >> hemingioma mri lumbosacral >> degenrative changes bone
>> hot uptake in D7 + STERNUM

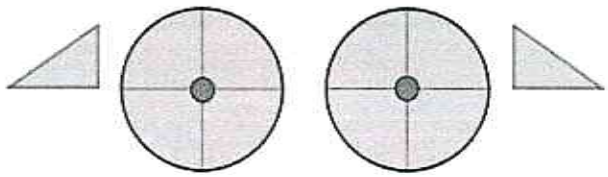
ER REVISION OF CT FILMS >> NO CHANGES IN STERNUM +
ENERATIVE CHANGES IN DORSAL AREA

MDT MEANWHILE FOR MRI DORSAL

**ommendations:**

OT METS OR OLIGO FOR NAct then It mrm

R L



TNM

**Outcome & Plan**

MRI dorsal spine then REMDT
nwhile to start AI/ZOLADEX until rolling out the nature of the spine lesion

## SIGNATURE

| DICAL ONCOLOGY | SURGERY | RADIOLOGY | PATHOLOGY | Nutrition | Psychiatric |
|---|---|---|---|---|---|
| anan Ezzat | | | | | |



MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]